

1-地域保健と保健統計

到達目標

- 地域保健の役割を説明できる
- 保健統計の概要と代表的な数字を説明できる

公衆衛生学II

2026-05-08

講師：佐上 徹（さがみとおる）



学校法人 栄戸学園

横浜未来看護専門学校

Yokohama Mirai Nursing School

地域保健



保健

● 職域保健

- ◆ 労働者の健康管理

● 医療保険者による保健

- ◆ 特定健康診査

● 学校保健

● 環境保健

● 広域保健

- ◆ 検疫
- ◆ 医療従事者の身分法

など

地域保健

対人保健

- 健康増進法
- 感染症法、予防接種法
- 母子保健法
- 精神保健福祉法
- その他
 - ◆ 難病医療法、がん対策基本法、
肝炎対策基本法 など

● 地域保健法

- ◆ 基本指針
- ◆ 保健所等の設置
- ◆ 人材確保

対物保健

- 食品衛生法
- 興行場法などの業法
- 水道法
- 墓地埋葬法
- その他
 - ◆ 狂犬病予防法、薬事法、
ビル管法、生衛法 など

医療

- 医療法
 - ◆ 病院の開設許可
 - ◆ 医療計画
- 薬事法
- 医療従事者の身分法
- 高齢者医療確保法
- がん対策基本法
- 医療観察法

など

福祉

- 介護保険法
- 身体障害者福祉法
- 知的障害者福祉法
- 児童福祉法
- 児童虐待防止法
- 障害者総合支援法
- 発達障害者支援法
- 精神保健福祉法
- 老人福祉法

など

地域保健の目的と役割

- 衛生活動の目的＝国民の健康の保持増進
- すべての地域の住民を対象とする
 - 保健衛生一般 ＋ 環境衛生・環境保健
- 地域住民全体を視野においた組織的な健康づくり
- 国や都道府県・市町村が施策を実施する

地域住民のうち、学校と職場は別

- 学校生活（学童・生徒と教員）を対象とする
 - 学校保健（講義第2回）
- 職場の生活を対象とする
 - 労働衛生・労働保健（講義第4回）

地域保健の活動は分野別・ライフステージ別

分野・領域	本講義	概要
母子保健	2 日目	母子保健法・母子健康手帳 など
感染症対策	3 日目	感染症法 予防接種の実施 など
難病・疾病対策	3 日目	難病医療法 がん対策基本法 など
精神保健福祉	4 日目	成人メンタルヘルス 自殺予防 など
成人・高齢者保健	5 日目	メタボリックシンドローム フレイル など

地域って何？

- 「地域」で生きている感覚ある？
 - まち 区 市 県 国 → 矢部町 戸塚区 横浜市 神奈川県 日本
- 例：住居は川崎市中中原区。家族の勤務先は東京都大田区。
自分の学校は横浜市戸塚区。買物は横浜と原宿と渋谷。バイトは武蔵小杉...

だいぶ前：住居・移動・職業の自由がなかった時代もあった

- 鉄道（明治時代1872年から）・自動車・高速道路・地下鉄（昭和中盤1960年以降）
- 日本の産業は江戸時代から1960年頃までの農業・漁業中心
- 家と農地・漁場（職場）の距離が近接している必要があった
 - この頃は「地域」で生きている感覚はあったはず

ちょっと前～いま

- 2005年頃 日本は人口減少社会に突入した
- 2005年頃 小さな市町村は大合併した
- 核家族化・単身世帯の割合が多くなった
- プライバシーを重視して「表札」を出さなくなった
- 隣の住人の名前と顔を知らないこともある

地域といっても、イメージするものは人それぞれ

- 「地域保健」という場合は、
区・市などの行政単位での弱者・潜在的弱者に対する取り組みと考えておく

どうして地域保健？ どうしてみんなの健康？

- 社会全体 = (いろいろなひと) ~多様性
- 医療職の目線では
 - 社会全体 = 健康な人 + 病気の人
 - 病院・診療所では患者としてやってくる「病気の人」だけを対象にする
 - 「健康な人」は住んでいる地域で「病気の人」になる
 - 病院で病気になるわけではない
 - 「病気の人」は住んでいる地域で治療を受ける・生活する
 - 病院ですべて治せるわけではない
 - 「病気の人」全員が通院・入院しているとは限らない

大きな視野で見る・看る・診る必要がある

- 自分の生活 みんなの生活 自分の健康 みんなの健康
- 患者の病気 患者の生活
 - いつか自分・家族も患者・病気・高齢者になる
 - 医療機関で「患者の病気」ばかり見ても仕方がない
 - 自分だけが「健康」になる・ありつづけることはできない

地域の中にはいろいろなひと

- 妊婦、小児、高齢者、治療中の病気がある人 など
- これから病気・不健康になるかもしれない人 = 潜在的弱者 = わたしたち

横浜未来看護専門学校・建学の精神 「One for ALL, ALL for One」

保健所・保健センターの役割

- それぞれ保健衛生行政の拠点
- 国（厚生労働省）―都道府県―保健所―市町村保健センター

保健所 462箇所 (2025年4月1日)

- 予防、健康増進、環境衛生を担う広域的、**専門的、技術的拠点**
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、放射線技師、保健師、臨床検査技師など

市町村保健センター 2391箇所 (2025年4月1日)

- 市町村レベル・地域住民に身近な対人保健サービスを行う
- 保健師が中心。**健康づくりの拠点**
- 保健サービス（母子保健 高齢者保健 がん検診など）を総合的に行う

健康づくりの戦略とその実践方法

- ハイリスク戦略とポピュレーション戦略

ハイリスク戦略

- 有病者・予備軍に対する個別の取り組み
 - リスクの高い特定の個人に焦点＋医学的方法
 - 健康診査・がん検診 保健指導 など

ポピュレーション戦略 population=人口・住民・集団全体

- 対象集団全体に対する取り組みで、全体に対して社会科学的な手法を用いる
 - 全体への情報提供 正しい知識の共有・展開
 - 生活習慣改善の環境整備

具体例（ハイリスク戦略とポピュレーション戦略）

- 肥満者に対して減量指導を行った
- 飲食店・学校給食と連動して野菜を食べようキャンペーン・食の教育を行った
- 健康増進法を改正。飲食店での喫煙・受動喫煙を禁止した
- 市民スポーツセンターを開設して、利用料を1日400円とした
- 48歳の乳がん検診の未受診者に対して、督促の手紙を送った

これらの取り組み：どの（ハイリスク、ポピュレーション）戦略だろうか？

- どちらがいい悪いということではない
- どちらも地域全体の病気のリスクを低下させる取り組み
- 複数組み合わせ合わせて継続的に行うことが重要

演習：話し合ってみよう

- ハイリスク戦略とポピュレーション戦略の違いは何だろうか？
 - （もしあるとして）同じところはどこ？
 - 違う（と思う）ところはどこ？
- ハイリスク戦略とポピュレーション戦略の例として何か思い浮かぶだろうか？

相手の意見・考えに耳を傾けてみよう

- 自分の考えと相手の考えはどう違う？
 - （もしあるとして）同じところはどこ？
 - 違う（と思う）ところはどこ？

自分の意見を持とう！伝えられるようになるろう！

- 私は～だと思う。
 - なぜなら～だからだ。
- × なんとなく・ネットに書いてあった・◎◎さんと同じ
- 自信を持って「まだ知らない・今はできない・わからない」と言おう
 - 講義前・講義後でわからなかったこと・わかったことはなんだろう？
- 「わからない」を「わからない」ままにしない
- ここがわからない→ここがわかるようになった
- ここがわかる・できるようになったので、こんなことが言える

予防の考え方

	1次予防	2次予防	3次予防
目的	病気にならない	早期発見・早期治療	素早い社会復帰
防ぐもの	病気の発症	重症になること	「死」・再発
手段	生活習慣の改善・予防接種 運動・禁煙・食事・ワクチン	がん検診・画像検査	治療そのものの リハビリ
対象	全員	ハイリスク者	診断後の患者

- 1次予防のほうが、全体・根本に対する取り組みで、手前・上流にある。
- 生活習慣病：がん、糖尿病、歯周病、心疾患、脳疾患

がん検診 地域（＝市町村） によるがん検診

- 対象とする臓器と年齢・間隔
 - 胃 50歳以上 2年間隔 上部消化管内視鏡
 - 大腸 50歳以上
 - 肺 50歳以上
 - 子宮 20歳以上 2年間隔 女性
 - 乳房 40歳以上 2年間隔 女性
- 早期発見と治療で集団全体の死亡率低下に効果があるものを対象
 - 検査方法に古臭いものも紛れている
 - 胸部レントゲン、胃透視検査（バリウム）
- 検診による早期発見が難しいがんがある（医学の限界） → 例：膵臓癌

こんなことも地域保健・保健所の仕事その1

水道の水質管理

公衆浴場・クリーニング業

理容業・美容業

墓地・ペット（墓地埋葬・狂犬病予防）

どうして？

- 生活衛生が悪いと何が起きる？

こんなことも地域保健・保健所の仕事その2

食品衛生・食中毒

- サルモネラ（鶏肉・鶏卵）
- 病原性大腸菌O-157など（牛肉）
- アニサキス（サバなど生魚）
- キノコ毒
- 黄色ブドウ球菌・ウェルシュ菌
- ノロウイルス などなど

どうして？

- 食品衛生が悪いと何が起きる？

「健康日本21」

- 「健康増進法」という法律による取り組み
- 最大の目標
 - 「生活習慣病（がん、心・脳血管疾患など）」を抑止
 - 日本人の死因の約50%を占める
- 健康寿命（病気にならずにいられる寿命）を延伸
- **健康格差**（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）対策
- 社会環境の質の向上

繰り返しになりますが...

- 生活習慣によって「健康な人」が「病気の人」になることが多い
- 医療機関で「病気」になるわけではない

「健康日本21」の現実的な目標（講師作成）

1. 栄養・食生活：質・量・時間帯を整える
2. 身体活動・運動：1日の歩数・運動をプラス1000歩・プラス10分
3. 休養・心の健康づくり：睡眠時間を7時間以上
4. タバコ：喫煙・受動喫煙をなくす
5. アルコール：1日の適切な量を知ろう（ビール350mlまで）
6. 歯の健康：大人になったら歯周病対策（歯間ブラシを使おう 歯科受診）など
7. 糖尿病：標準体重を知り、維持する
8. 循環器病：塩分を1日6-7.5グラム以下（**1食2-2.5グラム以下**）にする
9. がん：野菜と果物を取る・がん検診を受ける など

「健康」とは

WHO 憲章 世界保健機関 1946年

- 健康とは
身体的にも精神的にも社会的にも完全に良好な状態をいい、
単に病気がないとか病弱でないとかいうことではない

皆さんは健康ですか？

- 病気もないし健康？
- 病気はあるけど健康？
- 病気はないけど不健康？
- 病気もあってさらに不健康？

地域保健の基本指針（2015年 一部省略）

1. **ソーシャルキャピタル**を活用した自助及び共助の支援
2. 地域の特性をいかした**保健と福祉の健康なまちづくり**
3. 医療、介護及び福祉等の関連施策との**連携強化**
4. 健康**危機管理**体制の確保 1. 災害・新興感染症など
5. **学校保健との連携** 1. 食育、歯科保健、喫煙、休養・睡眠、運動習慣
6. **科学的根拠に基づいた**地域保健
7. 保健所の運営及び**人材確保**に関する事項
8. 快適で安心できる**生活環境**の確保
9. 国民の**健康増進及びがん対策**

演習：話し合ってみよう

- 保健と医療の違いは何だろうか？
 - （もしあるとして）同じところはどこ？
 - 違う（と思う）ところはどこ？

保健統計

保健統計を知る意味

- 国や地域でヘルスサービスを提供するためには、集団としての健康度、保健衛生、社会生活の状況を把握する必要がある
- その基礎となるデータが保健統計
 - 人口統計や疾病・傷病を把握する統計など

日本の社会の特徴

- 我が国の総人口¹は、2026年1月1日現在、1億2,295万人
- 65歳以上人口は、3,620万人(←高齢者も減少開始)
- 総人口に占める65歳以上人口の割合（高齢化率）は29.4%

人口は今後長期に渡って減少する

- 年少人口の急激な減少
- 高齢者割合の増加/高齢者数の減少

世帯（構成割合） 2023年国民生活基礎調査

- 世帯数：5445世帯
- 単独世帯：34.0%
- 核家族世帯：56.3%
- 三世代世帯：3.8%

「65歳以上」がいる世帯 49.5%

「65歳以上」がいる世帯のうち

- 単独世帯：31.7%
- 「65歳以上」のみの世帯：61.4%

高齢化率

- (65歳以上) 高齢者の総人口に占める割合
- 2026年で29.4%
- 2050年には高齢化率が37.1%となる予想

日本の高齢者人口の割合は、世界で最高 (201の国・地域中)

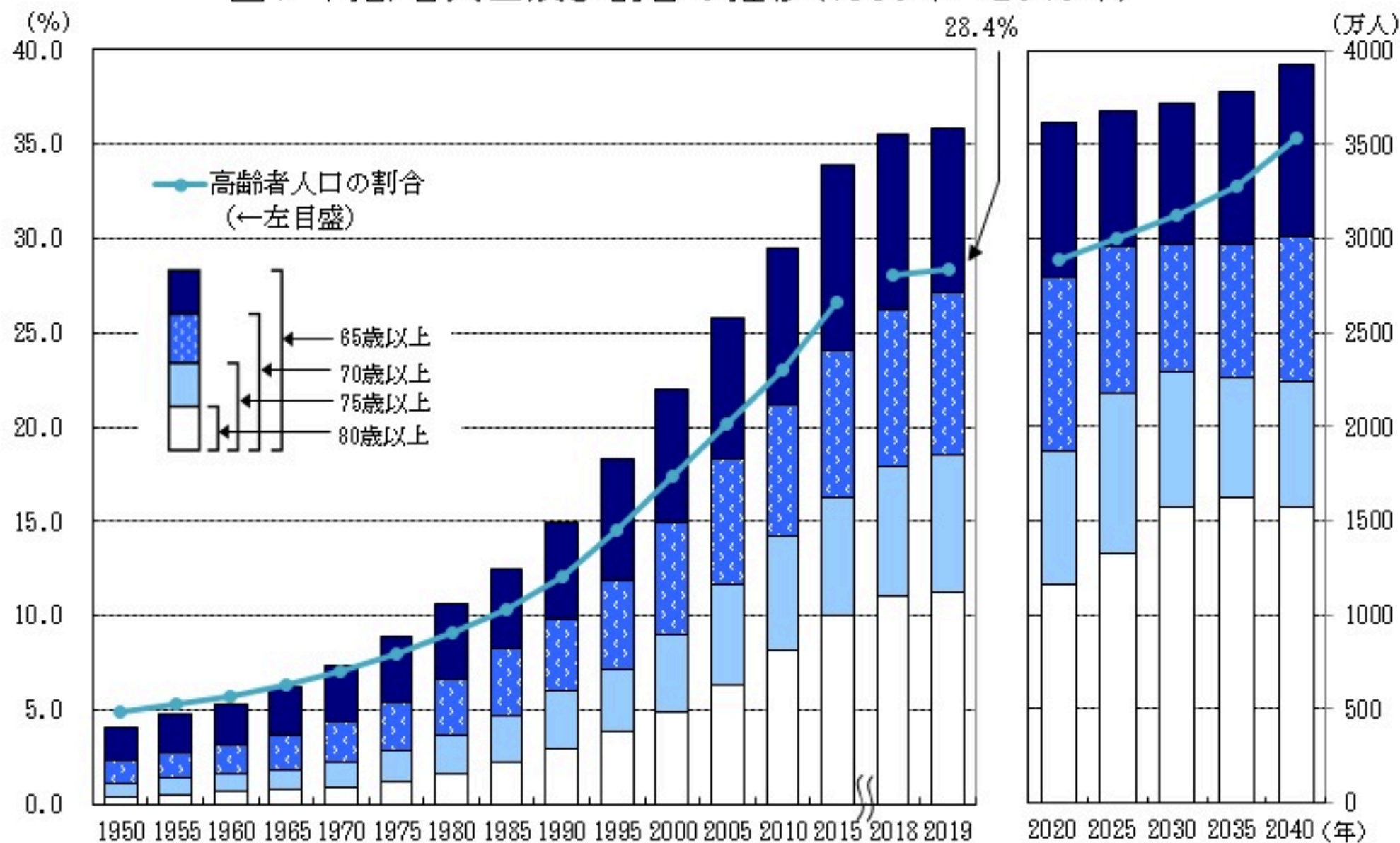
- 2024年の総人口に占める65歳以上人口の割合を比較すると、日本 (29.3%) は世界で最も高く、次いでマルティニーク (25.3%)、プエルトリコ (24.7%)、イタリア (24.6%)、ポルトガル (24.5%)、ギリシャ (23.9%)

出典：統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」にちなんで－ (総務省統計局)

日本の高齢化の歩み

	高齢化率	いつから	7%増えるのにかった期間
高齢化社会	7%	1970年	---
高齢社会	14%	1994年	24年間
超高齢社会	21%	2007年	13年間
現在🌕	29.4%	2026年	28.1%（2018年）まで2007年から11年
未来予想	37.1%	2050年	出典：国民衛生の動向

図1 高齢者人口及び割合の推移(1950年～2040年)



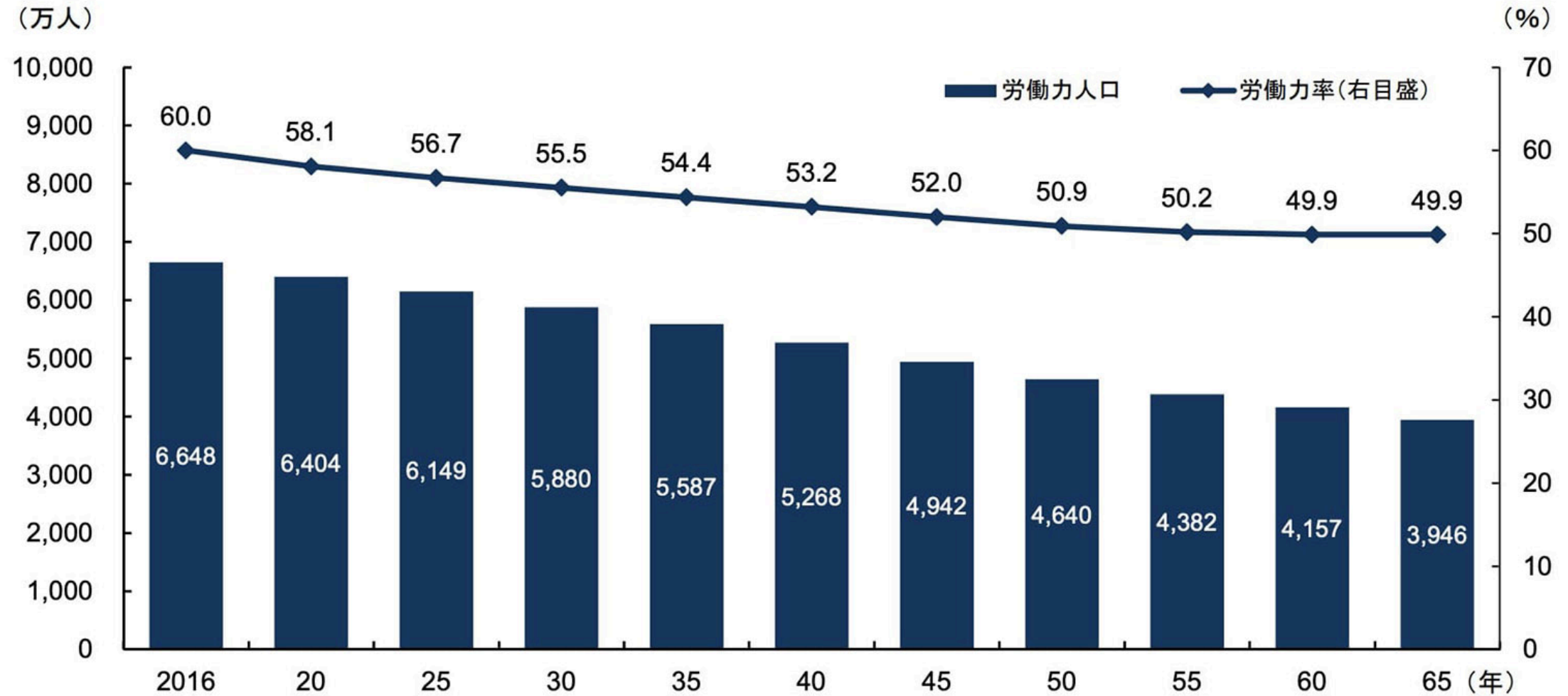
労働力人口

- 労働する意思・労働できる能力を持った15歳以上の人口
- 労働力人口7,004万人＝就業者＋完全失業者176万人
- 就業者数は6,828万人(2025年平均)
- 2030年に6,940万人
- 2040年に6,791万人

労働力率

- 15歳以上人口に占める労働力人口の割合のこと

労働力人口と労働力率の見通し



(注) 2016年は実績。2020年以降は、男女別、年齢5歳階級別の労働力率を2016年と同じとして算出（75歳以上は、2016年の75歳以上の労働力率を75～79歳の労働力率とし、80歳以上はゼロとして算出）。

出典：みずほ総研（資料）総務省「労働力調査年報」（2016年）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2017年4月推計）より、みずほ総合研究所作成

人口動態統計

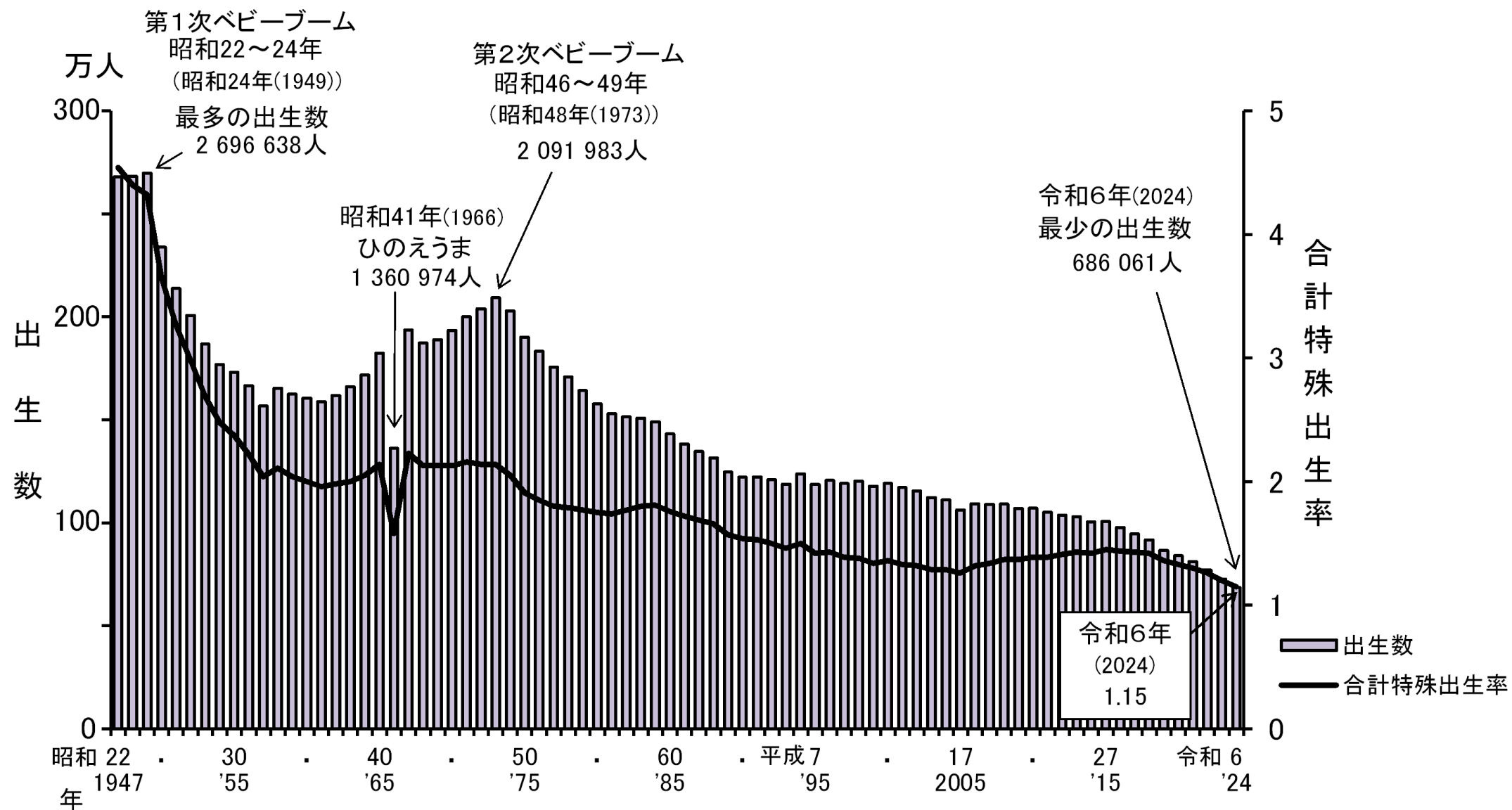
- 出生 死亡 死産 婚姻 離婚の5つの事象（人口が増減する要因となることから）
- 市町村の役所で「届」を提出する
- 保健所・都道府県を経由して国（厚生労働省）で情報収集されている
- 死亡届（死んだ人の家族等が書くもの）の右側は死亡診断書（医師・歯科医師が書くもの）
 - 死亡した場所・死因・手術の有無がわかる

人口動態統計 (2024年)	実数	率	用語・率の意味
出生	686,173	5.70	人口1000人あたりの出生
死亡	1,605,378	13.30	人口1000人あたりの死亡
自然増減	-919,205	-7.60	人口1000人あたりの出生と死亡の差
死産	15,323	21.80	出産（出生＋死産）1000あたりの死産（自然＋人工）
自然死産	6,849	9.80	出産（出生＋死産）1000あたりの自然死産
人工死産	8,474	12.10	出産（出生＋死産）1000あたりの人工死産
妊娠満22週以後の死産	1,800	2.60	
周産期死亡 ¹	2,285	3.30	出産1000あたりの周産期死亡
乳児死亡	1,266	1.80	出生1000人あたりの乳児（＝1歳未満）の死亡
新生児死亡	637	0.90	出生1000人あたりの新生児（＝28日未満）死亡
早期新生児死亡	485	0.70	出生1000あたりの早期新生児（＝7日未満）の死亡
婚姻	485,092	4.00	人口1000人あたりの婚姻
離婚	185,904	1.55	人口1000人あたりの離婚

¹ 周産期死亡＝妊娠満22週以後の死産＋早期新生児死亡

出生

- 2024年の年間の出生数は68.6万人 ←減少中
- 第二次ベビーブーム（1971-74年）と言われた、1973年（昭和48年）の年間の出生数は210万人
- 第一次ベビーブーム(1947-49年)と言われた1948年（昭和23年）生まれは268万人であった。この3年は250万人を超えている



合計特殊出生率

- 女性が一生のうちに生む子供の人数
- 2024年の合計特殊出生率は1.15人ぐらい
- 合計特殊出生率が2.1を下回ると人口が減ると言われている

平均寿命

- 2023（令和5）年 男性：81.09年、女性：87.14年
- 1990（平成2）年 男性：75.92歳、女性：81.90歳

将来予想

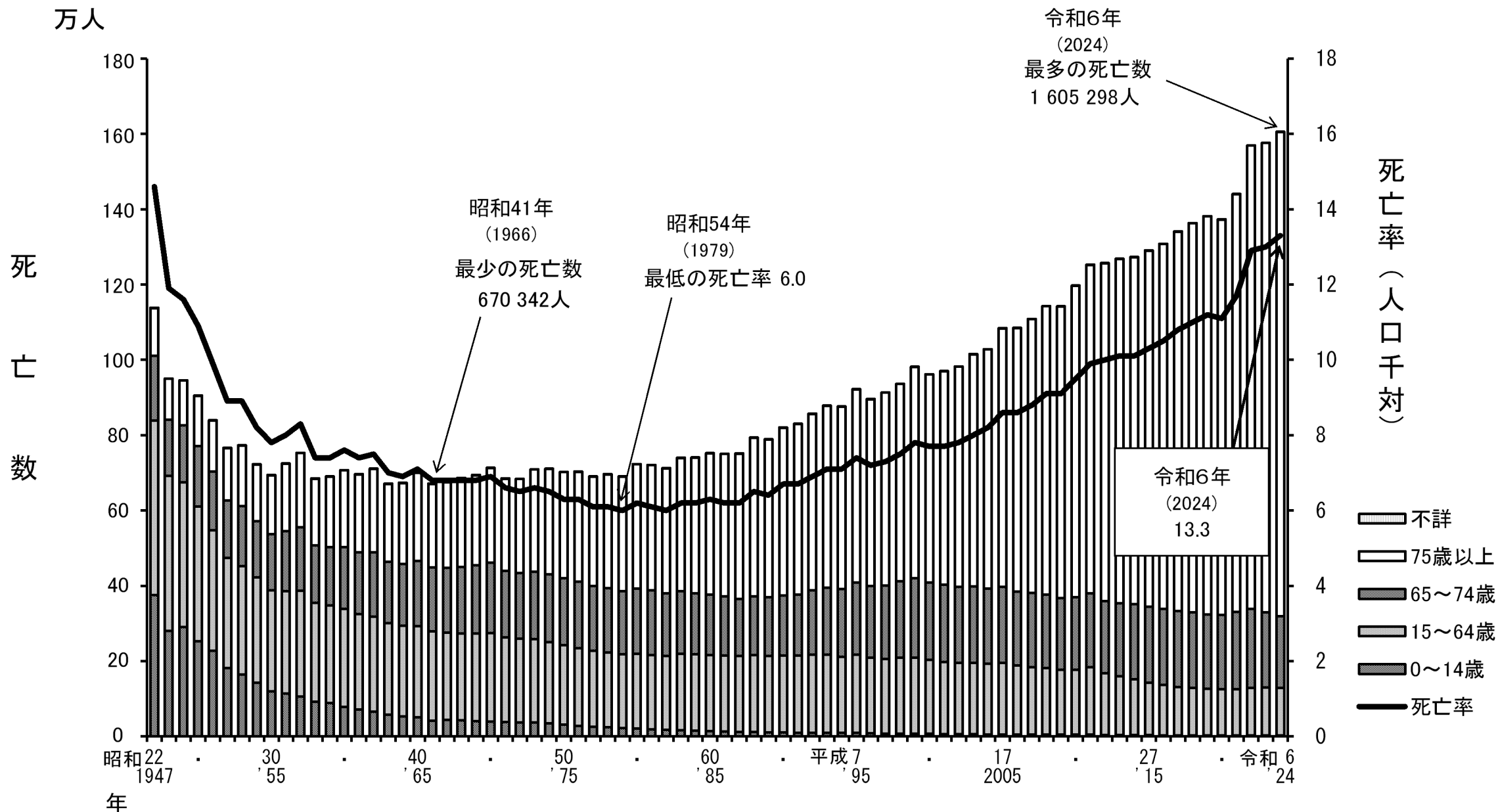
- 2040（令和22）年には男性83.27年、女性89.63年になると推計されている
- 2040年にかけても約2年伸びる見込み。平成の30年間に約5年以上伸びた。

寿命と健康は人口の動向にも影響する

- 健康なら長生きする
- 長生きするなら人口は減らない

死亡数・死亡率

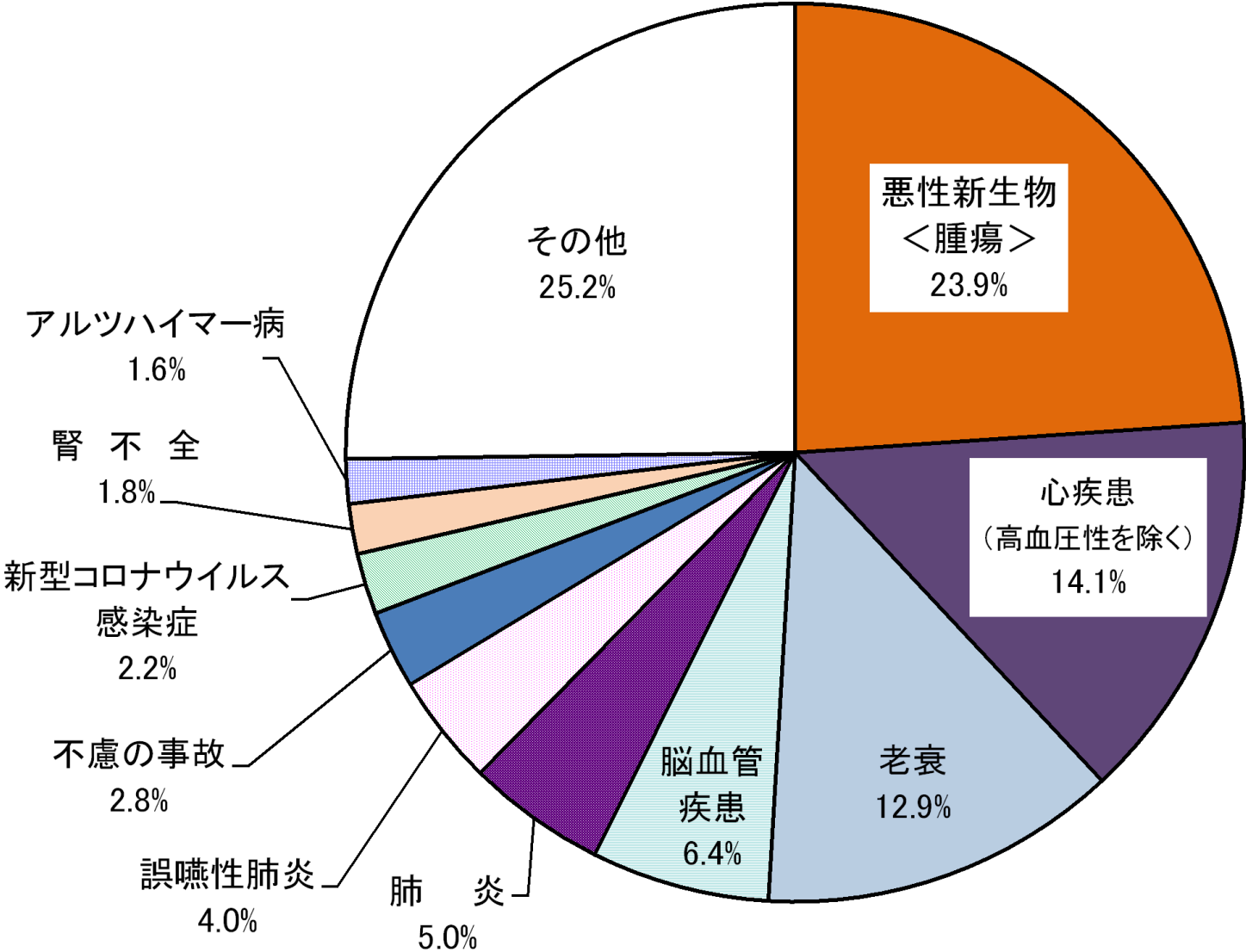
- 2024年は160.5万人の死亡
- 人口1000人あたりの死亡数（＝死亡率）は13.3
- 近年は死亡数・死亡率は増加



死因統計

2024年

順位	傷病
1位	がん
2位	心疾患
3位	老衰
4位	脳疾患
5位	肺炎
6位	誤嚥性肺炎



年齢階級別の死因順位と死亡数 ¹										
年齢区分	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数
全年齢	悪性新生物	384,099	心疾患	226,277	老衰	206,882	脳血管疾患	102,808	肺炎	80,171
0	先天奇形等	401	呼吸障害等	232	出血性障害等	51	不慮の事故	50	乳幼児突然死症候群	48
1	先天奇形等	104	不慮の事故	49	悪性新生物	47	心疾患	31	インフルエンザ	22
5	悪性新生物	81	不慮の事故	46	先天奇形等	40	インフルエンザ	21	その他の新生物	13
10	自殺	132	悪性新生物	95	不慮の事故	51	先天奇形等	35	心疾患	21
15	自殺	627	不慮の事故	166	悪性新生物	120	心疾患	46	先天奇形等	38
20	自殺	1,219	不慮の事故	241	悪性新生物	158	心疾患	72	先天奇形等	33
25	自殺	1,124	不慮の事故	247	悪性新生物	223	心疾患	104	脳血管疾患	45
30	自殺	1,120	悪性新生物	428	心疾患	211	不慮の事故	178	脳血管疾患	92
35	自殺	1,209	悪性新生物	902	心疾患	371	不慮の事故	269	脳血管疾患	258
40	悪性新生物	1,768	自殺	1,408	心疾患	682	脳血管疾患	588	不慮の事故	372
45	悪性新生物	3,913	自殺	1,720	心疾患	1,423	脳血管疾患	1,083	肝疾患	716
50	悪性新生物	7,699	心疾患	2,811	自殺	1,981	脳血管疾患	1,850	肝疾患	1,186
55	悪性新生物	11,330	心疾患	3,967	脳血管疾患	2,204	自殺	1,714	肝疾患	1,472
60	悪性新生物	17,061	心疾患	5,427	脳血管疾患	2,744	肝疾患	1,717	自殺	1,382
65	悪性新生物	27,568	心疾患	8,025	脳血管疾患	4,092	不慮の事故	1,896	肝疾患	1,820
70	悪性新生物	50,541	心疾患	15,126	脳血管疾患	8,067	肺炎	4,021	不慮の事故	3,672
75	悪性新生物	67,334	心疾患	23,020	脳血管疾患	12,402	肺炎	7,638	不慮の事故	5,801
80	悪性新生物	73,564	心疾患	35,044	老衰	18,273	脳血管疾患	17,583	肺炎	13,995
85	悪性新生物	64,695	心疾患	47,250	老衰	41,007	脳血管疾患	21,342	肺炎	19,813
90	老衰	66,648	心疾患	49,362	悪性新生物	41,488	肺炎	19,480	脳血管疾患	19,375
95	老衰	53,517	心疾患	27,353	悪性新生物	13,343	肺炎	9,708	脳血管疾患	9,202
100	老衰	19,719	心疾患	5,848	肺炎	1,910	脳血管疾患	1,818	悪性新生物	1,715

¹ 2024年

<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/xls/R6toukeihyou.xlsx> (access on 2026-02-10)

死因別 年齢階級別 からわかること

- がん（悪性新生物）：全体の第1位。40歳以降年齢階級別でも第1位
- 自殺：年齢階級別で10歳-39歳までは死因の第1位
- 心疾患：死亡数は脳疾患の死亡の2倍程度
- 老衰：80歳以降で増え、90歳以上で第1位となる（全年齢階級で第3位）
- 肺炎：65歳以降では死亡の順位が上がる
- 不慮の事故：小児から29歳までは第2-3位に

（0歳児は窒息。1-3歳児は溺水・交通事故が増える）

各年で細かな順位の変動はある。おおまかな傾向は知っておく ★

がんの部位別死亡順位(2024年)

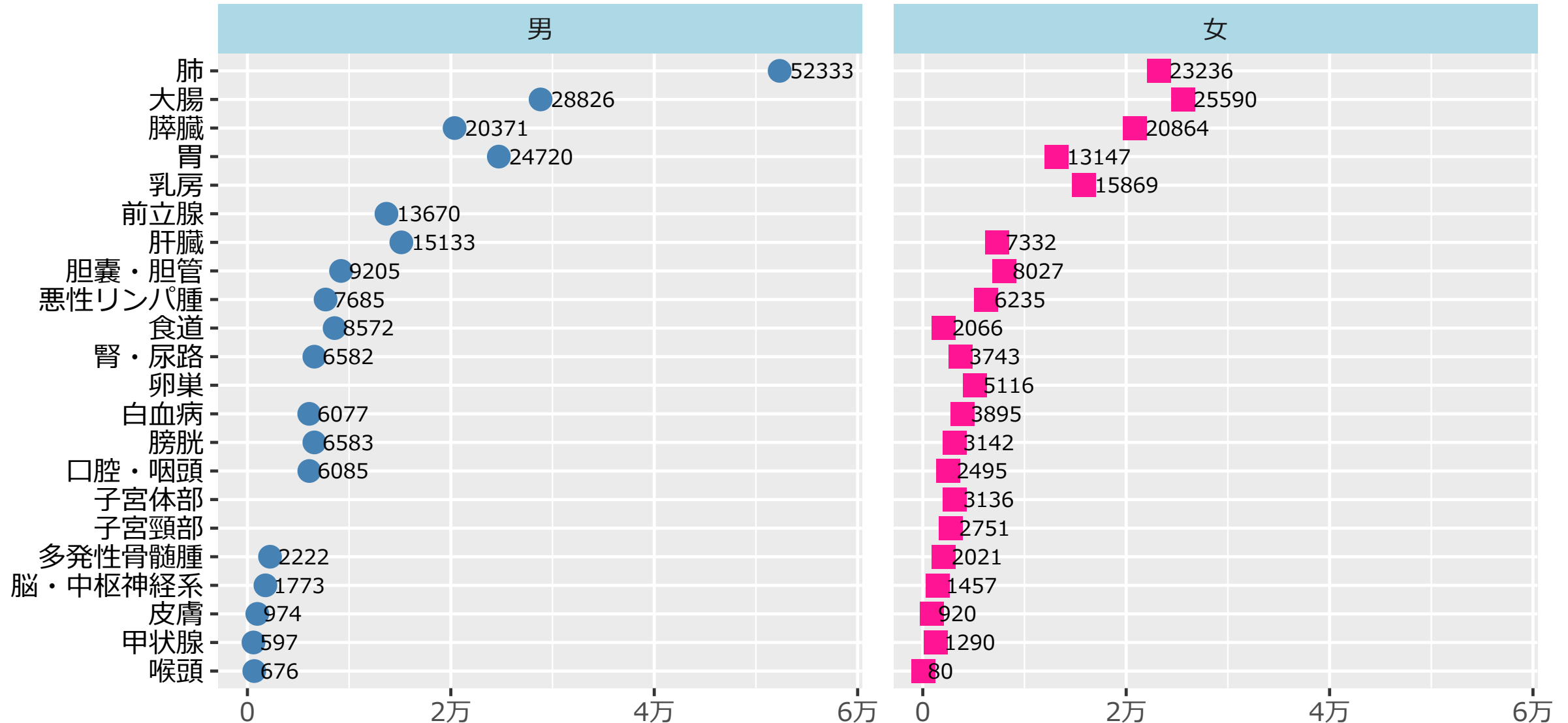
性別	1位	2位	3位	4位	5位
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃

がんの死亡統計 ★

- 1981年以降死因の第1位になった
- 死亡総数は男性が多い（男性21万 女性15万, 2024年人口動態統計）
- 胃：男女とも低下傾向　大腸：上昇していたが近年は横ばい
- 膵は微増

2024年 がん死亡数 男性 212,084人 女性 152,412人

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」 (厚生労働省人口動態統計)



出典: https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/dl/index.html (2026-02-13)

演習・課題

- 今日知ったこと・理解したこと・話したことをまとめてみよう
- 次回講義までに提出

再掲：到達目標

- 地域保健の役割を説明できる
- 保健統計の概要と代表的な数字を説明できる